🏥 医院导诊指南大全

📅 版本信息

文件名称：医院导诊指南大全（智能导诊系统知识库）
版本号：V1.0
生效日期：2025年12月

第 1 章：门诊服务指南

普通门诊就诊流程

适用科室（**Departments**）：

- 所有一级临床科室（如内科、外科、妇科、儿科、五官科等）

流程类型（**Process Type**）：registration

一、流程步骤（Steps）

1. 确认挂号：通过线上预约（App/微信/支付宝）、自助机或人工窗口完成挂号缴费。
2. 前往诊区：根据挂号单提示的楼层、诊区和诊室编号，前往相应候诊区域。
3. 分诊报到：到达诊区后，请在护士站或使用自助报到机进行电子签到。
4. 候诊呼叫：密切关注诊区屏幕显示的排队信息，等待系统语音或屏幕叫号。
5. 进入诊室：听到呼叫号码后，按提示进入对应诊室就诊。请将病历资料和挂号单递交给医生。
6. 医生问诊：配合医生完成病史询问、查体（体格检查）和开具检查/检验/治疗申请单。
7. 缴费：凭医生开具的电子或纸质申请单，使用自助机、线上支付或人工窗口进行缴费。
8. 检查/检验：依据申请单指引，前往指定地点完成检查或检验项目。
9. 复诊/取药：凭检查/检验结果返回原诊室复诊，或持处方单前往药房取药。

二、注意事项（Notes）

- 实名制：本院实行实名制就诊，请务必使用患者本人身份证、医保卡或电子健康卡。
- 迟到：若迟于挂号时间段到院，需重新报到并等待，就诊顺序可能延后。

- 有效时间：当日门诊号仅当日有效，如需次日就诊需重新挂号。
- 病历资料：首次就诊请购买病历本；复诊请携带所有历史检查检验报告和既往病历资料。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 无需特殊准备，但请提前了解是否需空腹（如需抽血）或携带既往资料。

专家门诊就诊流程

适用科室（**Departments**）：

- 所有设有主任医师、副主任医师职称的科室

流程类型（**Process Type**）：registration

一、流程步骤（Steps）

1. 预约挂号：专家门诊号源紧张，强烈建议提前1-7天通过官方App或微信公众号预约。
2. 确认号源：提前一天确认预约信息，了解专家当日停诊/调班情况。
3. 取号/缴费：就诊当日按预约时段提前30分钟到院，自助机或人工窗口取号并缴费。
4. 报到候诊：凭号前往指定专家诊区护士站报到。
5. 就诊：按照叫号系统指示进入诊室。
6. 检查/检验：医生开具检查后，完成缴费并优先安排检查。
7. 二次候诊：部分专家要求患者持检查结果返回诊室进行二次诊疗（请遵医嘱）。
8. 治疗/开药：专家完成诊断，开具处方或治疗单。
9. 离院：取药或安排后续治疗，结束当日就诊。

二、注意事项（Notes）

- 预约为先：专家号不接受现场当日加号，请务必提前预约。
- 诊查费：专家门诊诊查费高于普通门诊，具体费用以缴费单为准。
- 时间把握：专家号过号等候时间长，请严格按预约时间段到院。
- 提问准备：专家门诊时间宝贵，建议患者提前列好病史和需要咨询的问题清单。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 请务必携带所有关键的、与本次病情相关的影像学资料（如CT/MRI胶片或光盘 ）和病理报

告。

预约挂号指南（线上 & 线下）

适用科室（**Departments**）：

- 所有门诊科室

流程类型（**Process Type**）：registration

一、流程步骤（**Steps**）

1. 选择渠道：确定线上（官方App、微信、支付宝生活号）或线下（自助机、人工窗口、电话 ）预约。
2. 实名认证：首次预约需进行实名注册和身份认证（姓名、身份证号、手机号）。
3. 选择科室/医生：根据病情或医生职称需求，选择科室、日期和医生。
4. 确认时段：选择可预约的就诊时段（例如：上午 9:00-9:30）。
5. 支付：线上预约需提前支付挂号费（部分平台仅支持预留，到院再付）。
6. 接收凭证：预约成功后，系统将发送短信或App消息作为预约凭证。
7. 取号/确认：就诊当日按约定时间到院，使用凭证在自助机或窗口取号/确认。

二、注意事项（**Notes**）

- 放号时间：本院统一在每日 X 点（如 18:00）释放 Y 天后的号源。
- 取消/退号：如需取消，请在就诊前一天 Z 点（如 16:00）前通过原预约渠道办理。逾期未取消或未到诊视为失约。
- 黑名单制度：连续 N 次失约（如 3 次），将被系统计入黑名单，一定期限内无法进行线上预约。
- 非急重症：预约挂号仅适用于非急重症患者，急症请直接前往急诊科。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 线上支付时请确保账户余额充足，并注意保护个人信息安全。

候诊流程说明

适用科室（**Departments**）：

- 所有门诊、专家诊区

流程类型（**Process Type**）：guide

一、流程步骤（Steps）

1. 报到/签到：持当日挂号单或电子凭证，在诊区护士站或自助报到机上完成报到。
2. 核对信息：确认诊区屏幕显示您的姓名、序号和预计等候时间。
3. 安静候诊：在指定候诊区安静等候，请勿大声喧哗、吸烟或饮食。
4. 关注叫号：密切注意诊室门口上方屏幕或语音叫号系统。叫号通常会提示“请 序号/姓名 到 诊室编号 就诊”。
5. 过号处理：若听到叫号时未及时应答或离开候诊区导致过号，请立即向护士站说明情况。护士将安排您在等待3-5位患者后优先就诊。
6. 再次呼叫：医生完成上一位患者就诊后，系统将再次呼叫下一位患者。

二、注意事项（Notes）

- 听清号码：请仔细核对屏幕和语音叫号上的序号和姓名，避免错叫或误入。
- 离区需谨慎：检查、缴费等请在诊区附近活动，或在离开前告知护士，以便为您调整候诊顺序。
- 优先就诊：老年人、残疾人、军人、急危重症患者或特殊情况（如做完检查回诊 ）可联系护士寻求优先安排。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 请提前将病历、检查报告、医保卡等准备好，以便迅速进入诊室。

取药流程（门诊药房）

适用科室（**Departments**）：

- 门诊药房、中药房、急诊药房

流程类型（**Process Type**）：guide

一、流程步骤（Steps）

1. 处方开具：医生在诊室开具电子处方。
2. 处方审核/缴费：电子处方自动进入审方系统，患者完成缴费。
3. 药房配药：缴费成功后，药师收到配药指令开始调配药品。
4. 凭条获取：在门诊药房窗口附近的取药排队机上刷卡或扫码获取取药凭证（显示取药窗口号和排队号码）。
5. 等待叫号：关注药房上方的电子屏幕，等待叫号至对应窗口。
6. 核对取药：听到呼叫后，前往对应窗口，将取药凭证和病历本交给药师。药师将核对您的姓名、药品名称和数量。
7. 签字确认：确认药品无误后，在药师打印的凭条上签字，完成取药。

二、注意事项（Notes）

- 核对信息：收到药品时，请务必核对药品名称、规格、数量、用法用量，如有疑问立即向药师咨询。
- 特殊药品：胰岛素、疫苗等需冷藏药品，药师会提供冰袋或特殊包装，请尽快放入冰箱。
- 药品退换：药品一经发出，非药品质量问题，根据国家规定不予退换。
- 中药：中药饮片或代煎，请前往中药房窗口办理。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 保持安静，听从药房工作人员指引，请勿在发药窗口长时间逗留。

缴费流程（窗口、自助机、线上）

适用科室（**Departments**）：

- 门诊收费处、急诊收费处、各诊区自助机

流程类型（**Process Type**）：payment

一、流程步骤（Steps）

1. 开具清单：医生在电脑端开具处方、检查或检验申请单。
2. 选择缴费方式：人工窗口、自助机或线上支付（App/微信/支付宝）。
3. 窗口缴费（**Steps**）：
   - 在收费窗口排队。
   - 将就诊卡/医保卡和申请单递给工作人员。
   - 确认费用明细并选择现金、银行卡或医保支付。
   - 领取缴费票据。
4. 自助机缴费（**Steps**）：
   - 插入或刷取就诊卡/医保卡。
   - 选择“缴费”功能，系统自动调取未缴费用。
   - 确认明细后选择微信/支付宝/银行卡支付。
   - 打印缴费票据。
5. 线上缴费（**Steps**）：
   - 打开医院官方App或微信公众号，进入“门诊缴费”。
   - 绑定就诊人信息，查询未缴费账单。
   - 选择支付方式（微信/支付宝/银行卡）。
   - 支付成功，电子票据通常可在线查询或在自助机补打。

二、注意事项（**Notes**）

- 医保卡：使用医保卡缴费前，请告知工作人员是否需要医保报销，并确保医保卡已激活且账户状态正常。
- 票据保存：缴费票据是医保报销、单位报销和退费的重要凭证，请妥善保管。
- 缴费时限：检查、检验单通常在开具后 N 日内有效（如 3 日），请及时缴费。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 大额缴费（如 5000 元以上）或涉及特殊医保结算的，建议前往人工窗口办理。

智能导诊机使用说明

适用科室（**Departments**）：

- 门诊大厅、急诊大厅、各楼层分诊区

流程类型（**Process Type**）：guide

一、流程步骤（Steps）

1. 接触屏幕：轻触屏幕开始使用。
2. 选择功能：根据需求选择主界面功能，通常包含：
   - 智能导诊（根据症状推荐科室）。
   - 医院导航（科室/部门位置查询）。
   - 费用查询/缴费。
   - 打印报告单。
3. 智能导诊（Steps）：
   - 选择“智能导诊”或“问诊”。
   - 点击或输入您的主要症状（如：发热、咳嗽、腹痛）。
   - 依据屏幕提示，进一步选择症状的部位、性质、持续时间等。
   - 系统根据算法匹配出推荐就诊科室和医生（请注意，最终挂号仍需医生确认）。
4. 位置查询（Steps）：
   - 选择“医院导航”或“楼层指引”。
   - 输入目标科室名称（如：消化内科、CT室）。
   - 屏幕显示目标位置、所在楼层和最优路径图。
5. 打印/缴费：插入就诊卡，根据提示完成报告单打印或费用自助缴纳。

二、注意事项（Notes）

- 仅供参考：智能导诊结果仅为初步建议，不能代替医生诊断，最终挂号科室请结合自身病史或咨询导诊台护士。
- 保护隐私：使用自助机时，请注意保护个人信息，不要遗留卡片或单据。
- 报告时效：打印报告前请确认医生已签字或系统已发布结果。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 如遇机器故障或操作困难，请寻求附近导诊台工作人员帮助。

第 2 章：检查检验指南

血常规抽血流程

流程步骤：

1. 医生开单：医生开具血常规、生化等检验申请单。
2. 缴费：患者完成费用缴纳。

3. 取号/排队：前往抽血室（采血中心），使用条码在取号机上取排队号。
4. 等待叫号：关注叫号屏幕，等待系统呼叫到指定采血窗口。
5. 采血核对：进入采血室，将条码或就诊卡交给护士，护士将核对姓名、出生日期和检验项目。
6. 采血：护士在肘部或手背静脉进行穿刺采血。
7. 按压止血：采血完成后，立即用无菌棉签或棉球按压穿刺点 **5-10** 分钟，切勿揉搓。
8. 离开：确认无出血后，即可离开。

检查前准备：

- 空腹要求：若开具的检验项目包含血糖、血脂、肝功能、肾功能等，则需要空腹 **8-12** 小时（禁食、禁饮水，可饮少量白开水）。单纯血常规可不空腹。
- 时间：建议在上午 10:00 前完成采血，以保证检验结果的准确性。
- 衣着：穿宽松衣物，方便暴露手臂。

检查后注意事项：

- 采血后 24 小时内避免重体力劳动或提重物。
- 如出现晕血或头晕，请立即告知护士，平卧休息。

适用人群：成人/儿童（儿童采血可能使用指尖血或专用采血室）

尿常规 / 大便常规流程

流程步骤：

1. 缴费领容器：缴费后凭检验单或缴费凭证到护士站或指定窗口领取无菌采样容器。
2. 留取样本：前往卫生间留取样本。
3. 尿常规（**Steps**）：留取中段尿（先排弃开始的一小段，再接取中间段，最后一段排弃）。样本量约 10 mL。
4. 大便常规（**Steps**）：留取新鲜大便，取米粒大小，最好包含粘液或血液部分。
5. 送检：立即将样本送至检验科或指定的样本接收窗口。
6. 等待结果：依检验科告知的等待时间，通过自助机或App打印报告。

检查前准备：

- 尿常规：女性应避开生理期；采集中段尿可减少污染。
- 大便常规：无特殊准备，但要求留取新鲜样本（最好在排泄后 30 分钟内送检 ）。

检查后注意事项：

- 样本容器盖必须拧紧，避免污染。
- 如需留取 24 小时尿液，请严格按照医嘱和护士指导进行收集。

适用人群：成人/儿童

心电图检查流程

流程步骤：

1. 医生开单/缴费：完成心电图申请和缴费。
2. 前往心电图室：根据指引前往心电图室。
3. 登记排队：递交申请单登记，等待叫号。
4. 检查准备：进入检查室，平躺在检查床上，暴露胸部、四肢，放松身体。
5. 贴电极：检查人员在胸部、四肢踝关节和腕关节处涂抹导电膏并粘贴电极片。
6. 采集记录：机器自动采集心电信号，过程约 3-5 分钟。
7. 检查结束：取下电极片，擦除导电膏，穿好衣物。
8. 等待报告：等待医生打印或发送报告。

检查前准备：

- 休息：检查前需休息 10-15 分钟，避免剧烈运动。
- 衣着：穿易于穿脱和解开胸部衣物的服装。
- 携带：携带既往心电图报告（如适用）供医生参考。

检查后注意事项：

- 检查结束后可立即恢复正常活动。
- 报告有时需医生审核后才能领取，请咨询检查室工作人员。

适用人群：成人/儿童

B 超检查流程

流程步骤：

1. 开单/缴费：完成 B 超（超声）申请和缴费。
2. 预约/排队：部分超声项目需提前预约，未预约项目按排队号等待。
3. 登记：到超声科室报到。
4. 等待叫号：在候诊区安静等待。
5. 检查：叫号后进入检查室，平卧于检查床上，暴露检查部位。
6. 涂耦合剂：检查人员在检查部位涂抹耦合剂（无毒无害，水溶性）。
7. 探查记录：检查人员使用探头进行扫查和影像记录。
8. 擦拭离场：检查结束后擦去耦合剂，整理衣物后离场。

检查前准备：

- 腹部（肝胆胰脾）：需空腹 **8** 小时（禁食、禁水）。
- 泌尿系（膀胱、前列腺**/**子宫附件）：需憋尿，使膀胱充盈，请在检查前 2-3 小时饮水 500-1000 mL。
- 妇科（经阴道）：需排空尿液。
- 甲状腺、乳腺、血管等：无特殊准备。

检查后注意事项：

- 检查结束后可立即进食或排尿。
- 检查报告请耐心等待，或按通知时间领取。

适用人群：成人/儿童

CT 检查流程

流程步骤：

1. 医生开单：医生开具 CT 检查申请单。
2. 缴费**/**预约：缴费并按要求前往 CT 室预约检查时间（急诊和住院患者可优先）。
3. 领取指引：预约时领取检查指引单（如需增强扫描，会告知造影剂相关说明）。
4. 报到**/**准备：按预约时间到达 CT 室，报到后更换检查服，取下金属物品。
5. 签署知情同意：增强 **CT** 需签署知情同意书，并进行静脉穿刺准备。
6. 检查：进入检查室，平卧于检查床上，遵医嘱保持特定姿势或进行呼吸配合（吸气、屏气）。
7. 增强扫描（如需）：护士通过静脉注射造影剂。注射时可能会有全身发热感，属正常现象。
8. 结束：检查结束后，按压穿刺点，整理衣物离场。

检查前准备：

- 空腹：增强 **CT** 需空腹 **4** 小时。
- 金属物：取下所有金属物品（项链、眼镜、假牙、发夹、含金属的衣物）。
- 过敏史：增强 CT 前需告知医生和技师碘造影剂过敏史、哮喘史、肾功能不全史。

检查后注意事项：

- 造影剂：增强 CT 后多饮水（如 1000 mL）帮助造影剂排泄。
- 穿刺点：按压穿刺点至少 15 分钟。
- 留观：增强 CT 检查后需在 CT 室外留观 30 分钟，无异常方可离院。

适用人群：成人/儿童

核磁共振 MRI 流程

流程步骤：

1. 医生开单/缴费：完成 MRI 申请和缴费。
2. 预约：MRI 需较长时间，需提前预约。
3. 填表/核查：填写 MRI 安全检查表，向技师汇报体内有无金属植入物（如心脏起搏器、金属内固定、人工耳蜗）。
4. 更换衣物：更换医院提供的检查服，彻底取下所有金属和电子物品（包括手机、磁卡）。
5. 检查：进入检查室，平卧于检查床上，技师将为您佩戴耳机以隔绝机器噪音。
6. 采集：检查过程中机器会发出巨大噪音，请保持静止不动，并遵医嘱进行呼吸配合。
7. 结束：检查结束后，确认无不适后离场。

检查前准备：

- 禁忌症：携带心脏起搏器、脑动脉瘤夹（铁磁性）、某些金属假体者严禁进行 MRI 检查。
- 空腹：腹部 MRI 检查通常要求空腹 4-6 小时。
- 金属物：绝对禁止携带任何铁磁性物品进入 MRI 检查区域。

检查后注意事项：

- 检查时间较长（ 30 分钟至 1 小时 ），可能导致头晕或不适，休息片刻后可离院。
- 检查报告通常需 1-3 天出具。

适用人群：成人/儿童（儿童常需镇静或麻醉下进行）

胃镜检查流程

流程步骤：

1. 医生开单/缴费：完成胃镜申请（普通/无痛）。
2. 预约：预约胃镜检查日期和时间。
3. 术前检查：按医嘱完成血常规、凝血功能等术前检查。
4. 签署同意书：签署胃镜知情同意书。无痛胃镜需签署麻醉知情同意书。
5. 准备：按预约时间到内镜中心，更换衣物，取下活动假牙。
6. 检查：
   - 普通胃镜：咽喉部喷洒麻醉剂，左侧卧位，配合医生吞咽内镜。
   - 无痛胃镜：麻醉医生静脉给药麻醉，患者在睡眠状态下完成检查。
7. 结束：检查结束后，观察休息。

检查前准备：

- 空腹：检查前必须空腹 **8** 小时以上（包括水）。
- 停药：告知医生正在服用的药物，阿司匹林、氯吡格雷等抗凝药物可能需按医嘱停用。
- 家属陪同：无痛胃镜必须有家属陪同，且检查当日禁止驾车。

检查后注意事项：

- 普通胃镜：检查后 2 小时内禁食、禁饮，待咽部麻醉作用消失后再进食。
- 无痛胃镜：检查后需在复苏室留观 1-2 小时。当日禁止高空作业、开车、签署重要文件。
- 不适：如出现腹痛、呕血、黑便等症状，请立即就医。

适用人群：成人/儿童（儿童极少行普通胃镜）

肠镜检查流程

流程步骤：

1. 医生开单/缴费：完成肠镜申请（普通/无痛）。
2. 预约：预约肠镜检查日期和时间。
3. 术前检查/同意书：同胃镜。
4. 肠道准备：最关键步骤，按医生指导服用清肠药物（如聚乙二醇电解质散），并遵循低渣饮食要求。
5. 检查：按预约时间到内镜中心。
6. 进镜检查：左侧卧位，肠镜从肛门插入，检查整个结肠。
7. 结束：检查结束后，观察休息。

检查前准备：

- 低渣饮食：检查前 3 日开始低渣饮食（禁食蔬菜、水果、高纤维食物）。
- 清肠：检查前一日或当日晨按医嘱服用足量清肠药，确保排泄物呈清水样。
- 空腹：检查当日禁食、禁水。
- 家属陪同：无痛肠镜必须有家属陪同，且当日禁止驾车。

检查后注意事项：

- 胀气：检查后可能会有腹胀感，多走动可帮助排气。
- 饮食：检查后可从流质、软食开始逐步恢复正常饮食。
- 出血：如出现持续性腹痛、大量鲜血便，立即告知医护人员或就医。

适用人群：成人/儿童（儿童肠镜检查较少见）

胸片 / DR 检查流程

流程步骤：

1. 医生开单/缴费：完成胸片或 DR（数字化 X 射线摄影）申请。
2. 前往放射科：根据指引前往放射科 DR/X 光室。
3. 登记排队：递交申请单，取号排队。
4. 准备：进入检查室，脱掉上半身带有金属或高密度材质的衣物（如文胸、项链、带拉链的衣服）。
5. 检查：听从技师指示，进行特定的站立姿势（如背靠、侧立），配合吸气后屏住呼吸。
6. 采集：技师操作机器进行曝光拍摄。
7. 结束：检查结束，整理衣物离场。

检查前准备：

- 去除金属：必须去除检查部位所有金属物品。
- 妊娠：孕妇或备孕女性请务必告知医生和技师，以评估辐射风险。

检查后注意事项：

- 检查过程有少量辐射，但对人体影响极小，无需特殊处理。
- 报告通常在当日或次日出具。

适用人群：成人/儿童

第 3 章：急诊服务指南

夜间急诊流程

流程步骤（**Steps**）：

1. 到达分诊台：到达急诊大厅，向分诊台护士出示就诊卡或身份信息。
2. 分诊评估：护士根据病情进行分诊（评估心率、血压、体温等生命体征），判断危重程度和就诊区域。
3. 挂号缴费：根据分诊级别，前往急诊挂号收费窗口或自助机完成挂号和首次诊查费缴纳。
4. 候诊：依分诊指引前往对应诊区（如内科急诊、外科急诊、抢救室）候诊。危重症患者直接送抢救室。
5. 医生诊疗：医生根据病情进行问诊、查体并开具检查/检验/处置医嘱。
6. 检查/输液：缴费后立即进行必要的检查（如急查血、心电图、急诊 B 超）或输液治疗。
7. 观察/留观/离院：治疗或观察结束后，医生评估病情。病情稳定者开具医嘱离院；病情需进一步观察者办理留观；危重者收入院治疗。

注意事项（**Notes**）：

- 急诊优先：急诊就诊顺序遵循病情危重程度优先原则，而非挂号顺序。
- 检查时效：急诊检验检查报告通常优先出具。
- 保持安静：急诊区域人多且病情复杂，请保持安静，听从医护人员指挥。

急诊分诊规则（红/黄/绿分级 ）

流程类型（**Process Type**）：emergency

一、流程步骤（Steps）

1. 分诊报到：患者或家属抵达急诊，向分诊护士说明主诉（最主要的症状）。
2. 生命体征监测：护士采集体温、脉搏、呼吸、血压、血氧饱和度等关键生命体征。
3. 快速评估：护士根据患者症状和体征，依照五级分诊标准进行快速评估。
4. 定级分流：
    - 一级（红色，濒危）：心跳呼吸骤停、休克、大出血等。立即进入抢救室。
    - 二级（橙色，危重）：严重胸痛、意识障碍、急性呼吸衰竭等。立即进入抢救室或急诊监护室，争取 10 分钟内就诊。
    - 三级（黄色，急症）：持续性腹痛、中度外伤、体温 > 39°C。优先就诊，争取 30 分钟内就诊。
    - 四级（绿色，非急症）：普通发热、慢性病复诊、轻微外伤。普通门诊区域候诊，争取 60-120 分钟内就诊。
    - 五级（蓝色，等待）：仅需开药、换药、取报告。等待时间较长。
5. 指引就诊：护士指引患者前往对应级别的诊区或抢救室。

二、注意事项（Notes）

- 客观描述：请家属客观、准确描述病情，勿隐瞒或夸大，以利于准确分级。
- 级别变动：候诊期间如病情加重，请立即告知分诊护士，以便重新评估分级。
- 非急症：慢性病、体检报告解读等非急症需求，请挂普通门诊，以保障急危重症患者的抢救通道。

急诊输液流程

流程类型（**Process Type**）：emergency

一、流程步骤（Steps）

1. 医生开输液医嘱：急诊医生根据病情开具输液处方。
2. 缴费：患者或家属至急诊收费处或自助机缴费。
3. 药房发药：凭缴费单到急诊药房领取输液药品。
4. 输液室报到：前往急诊输液室，将药品和输液卡交给护士。
5. 核对/准备：护士核对药品和剂量，准备输液器具。
6. 输液：护士为您进行静脉穿刺并开始输液。
7. 留观：输液期间，请留在输液区域，如有任何不适（如瘙痒、头晕、心慌），立即按呼叫铃或告知护士。
8. 拔针：输液完毕，护士进行拔针和穿刺点止血。

二、注意事项（Notes）

- 过敏史：务必在输液前主动告知护士所有药物过敏史。
- 液体观察：输液过程中请勿自行调节滴速，并注意观察输液局部有无肿胀、疼痛。
- 儿童：儿童输液需在专门的儿童输液区，由家长全程陪同看护。

急诊留观说明

流程类型（**Process Type**）：emergency

一、流程步骤（Steps）

1. 医生评估：急诊医生评估患者病情，认为需要 4-72 小时短期密切观察，但尚未达到住院标准。
2. 开具留观医嘱：医生开具留观医嘱和留观通知单。
3. 缴费：办理留观预缴金的缴纳。
4. 入住留观室：患者由护士指引至急诊留观室病床。
5. 生命体征监测：留观期间，医护人员将定期监测生命体征、观察病情变化。
6. 检查/治疗：在留观室完成后续的检查、检验或输液治疗。
7. 留观结束：
    - 好转：医生开具医嘱，办理出院手续。
    - 病情加重：医生开具住院医嘱，转入住院病房。

二、注意事项（Notes）

- 观察时间：急诊留观旨在短期观察病情，一般不超过 72 小时。
- 陪护：留观患者通常需有一名家属陪护。
- 贵重物品：请妥善保管个人财物，留观室不负责保管。

急诊收费与取药流程

流程类型（**Process Type**）：payment | guide

一、流程步骤（Steps）

1. 医生开单：医生开具检查/药品医嘱。
2. 收费窗口：前往急诊大厅收费窗口或急诊自助机。
3. 缴费：使用就诊卡、医保卡或电子支付完成缴费。
4. 取药：凭缴费单或处方至急诊药房窗口取药。
5. 核对：取药时务必核对姓名、药品名称、用法用量。
6. 检查安排：缴费后的检查项目（如 CT、B 超、化验）按急诊优先原则，由急诊护士或相关科室安排。
7. 补打发票：如需正式发票用于报销，请在病情稳定后凭缴费记录至急诊收费窗口补打。

二、注意事项（Notes）

- 医保：医保患者请提前告知收费人员，并确保医保卡可用。
- 药品：急诊药房仅配备急救和急症常用药，部分特殊药品可能需至门诊药房取。
- 优先级：急诊检查项目排队优先级高于普通门诊。

第 4 章：住院与出院服务指南

住院办理流程

流程类型（**Process Type**）：inpatient

一、流程步骤（Steps）

1. 医生开具住院证：门诊/急诊医生评估病情后，认为需住院治疗，开具《住院证》。
2. 办理手续：患者（或家属）持《住院证》、身份证、医保卡/就诊卡，前往住院收费处。
3. 录入信息：工作人员核对并录入患者身份信息和医保信息。
4. 预缴金缴纳：按要求缴纳住院预缴金（现金、银行卡、电子支付）。
5. 领取住院通知单：领取盖章后的《住院通知单》（包含病区名称、床位号等）。
6. 送至病区：患者持《住院通知单》和所有病历资料，由家属或护工陪同前往指定病区。
7. 病区报到：向病区护士站报到，护士核对信息后，指引至床位并进行入院宣教。

二、注意事项（Notes）

- 医保手续：医保患者需在入院时办理医保登记手续，跨省/市医保需提供相应备案材料。
- 证件齐全：办理住院时务必携带身份证原件，儿童需携带户口本或出生证明。
- 等待床位：若无空余床位，需在住院处登记排队，等待通知入院。

三、检查前准备 / 补充说明（如适用）

- 建议入院时携带少量必需品，如洗漱用品、换洗衣物和日常用品。

入院宣教内容

流程类型（**Process Type**）：guide

一、流程步骤（Steps）

1. 护士迎接与环境介绍：护士站护士迎接患者，介绍病区环境（洗手间、开水间、护士站、医生办公室位置）。
2. 安全宣教：告知消防安全、防跌倒措施（如床栏使用）、禁止吸烟等规定。
3. 生活制度：介绍病区作息时间（查房时间、治疗时间、探视时间、熄灯时间 ）。
4. 医患沟通：介绍主管医生、责任护士姓名，告知医生查房和询问病史的重要性。
5. 陪护探视制度：告知陪护证的办理和使用规定，介绍探视时间，非探视时间谢绝来访。
6. 费用告知：告知每日费用查询方法（如自助机、App），提醒预缴金余额。

二、注意事项（Notes）

- 遵守制度：患者及陪护人员须严格遵守病区管理制度。
- 主动询问：对不清楚的治疗、检查安排或疑问，请主动向主管医生或责任护士询问。
- 保护隐私：查房或进行治疗时，注意保护个人隐私。

住院期间的检查流程说明

流程类型（**Process Type**）：exam

一、流程步骤（Steps）

1. 医生开医嘱：主管医生开具检查申请单。
2. 护士准备：护士站打印申请单，通知患者检查前准备事项（如空腹、备皮等）。
3. 预约安排：护士或专人与检查科室（如 CT/MRI 室、超声科）联系，安排检查时间。
4. 等待通知：患者在病房等待，护士或通知员将告知确切检查时间和集合地点。
5. 转运/检查：患者由护士或陪护人员（有时是专职运送人员）陪同，按时前往检查地点。
6. 检查过程：听从检查科室医技人员指挥完成检查。
7. 返回病房：检查结束后，返回病房。若进行特殊检查（如胃肠镜），需在病房休息观察。
8. 结果回传：检查结果由专人或系统自动传回病区，供医生查阅。

二、注意事项（Notes）

- 空腹/禁水：需空腹检查（如腹部超声、胃镜）的患者，请严格遵守护士的禁食/禁水通知。
- 穿刺点：介入或增强检查后，请严格按压穿刺部位，防止出血。

费用结算说明

流程类型（**Process Type**）：payment

一、流程步骤（Steps）

1. 日常查询：患者或家属通过病区自助查询机或官方App，每日查询费用发生情况。
2. 预警通知：护士或系统在预缴金余额不足时，会通知患者及时补缴。

3. 补缴：患者可选择在病区自助机、住院收费处或线上渠道补缴。
4. 出院结算：医生确认出院后，护士通知患者前往住院收费处办理结算。
5. 窗口结算：收费员核对住院期间总费用，医保患者进行医保报销结算。
6. 退/补费用：结清费用，多退少补。
7. 领取发票：领取住院费用总清单和发票，完成结算。

二、注意事项（Notes）

- 费用质疑：对费用清单有疑问，请立即向住院收费处或病区医生/护士提出。
- 医保清单：医保结算清单是报销重要凭证，请妥善保管。

出院办理流程

流程类型（**Process Type**）：inpatient

一、流程步骤（Steps）

1. 医生通知：主管医生告知患者次日或当日出院。
2. 办理结算：护士通知患者家属前往住院收费处办理费用结算。
3. 领取出院医嘱：家属持结算凭证返回病区护士站。护士准备好出院记录、长期医嘱、出院带药。
4. 出院宣教：责任护士对患者进行出院后的注意事项、复诊时间、伤口护理、用药指导等宣教。
5. 清点物品：患者清点个人物品，退还病房钥匙、餐具、病员服等医院物资。
6. 离院：患者在规定时间内离开病房。

二、注意事项（Notes）

- 带药：请仔细核对出院带药的种类、数量和用法用量。
- 复诊：务必牢记出院记录上记载的复诊时间和科室。
- 特殊物品：植入物、病理切片等特殊物品，请按医嘱要求领取和保管。

出院后的注意事项

流程类型（**Process Type**）：guide

一、流程步骤（Steps）

1. 遵循医嘱：严格按照医生在《出院记录》或《长期医嘱》上列明的用药、饮食、活动等指导。
2. 用药管理：按照规定的剂量、频次服用带回家的药物，切勿自行更改药量或停药。
3. 伤口护理（如适用）：保持手术伤口清洁干燥，按时换药。如出现红肿、渗液、发热，立即就医。
4. 饮食调整：按照疾病恢复期的饮食建议进行调整，避免辛辣刺激、过油或生冷食物。
5. 适当活动：遵医嘱进行康复锻炼，避免剧烈运动。
6. 定期复查：按时到门诊进行复查，医生会根据复查结果调整后续治疗方案。

二、注意事项（Notes）

- 紧急情况：出现病情反复、突发剧烈疼痛、高热不退、大出血等紧急情况，请立即返回急诊科就诊。
- 康复指导：如需进一步康复治疗，请咨询医生并前往康复科。

出院复诊流程

流程类型（**Process Type**）：registration

一、流程步骤（Steps）

1. 确认复诊时间：根据出院记录或医生口头告知，确认复诊日期和科室。
2. 预约挂号：通过线上渠道或电话提前预约复诊医生的门诊号。
3. 准备资料：整理住院期间的出院记录、检查报告、手术记录等所有资料。
4. 门诊就诊：按门诊流程挂号、报到、候诊。
5. 向医生汇报：就诊时向医生汇报出院后至复诊期间的病情变化、用药反应、康复进展等。
6. 后续安排：医生根据情况开具检查、调整药物或安排下次复诊。

二、注意事项（Notes）

- 带齐资料：务必带齐所有出院资料，这将有助于医生快速了解住院情况和后续治疗。
- 按时复诊：规律复诊对疾病的长期管理和恢复至关重要。

第 5 章：科室就诊指引

心内科（心血管内科）

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 胸闷、胸痛、心悸（心慌）、气短、呼吸困难。
  - 高血压、冠心病、心绞痛、心力衰竭、心律失常、高脂血症（血脂高）。
  - 心电图异常或既往有心脏病史需复查者。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 测量血压/体重 $\rightarrow$ 医生问诊 $\rightarrow$ 初步评估（听诊、查体）$\rightarrow$ 开具检查。
- 需要准备的资料：既往所有心电图、心脏超声、冠脉 CT/造影报告，以及服药清单。
- 常见检查：
  - 心电图（ECG）。
  - 动态心电图（**Holter**）：监测 24 小时心律。
  - 心脏彩色超声：评估心脏结构和功能。
  - 运动平板试验：评估心肌缺血。
  - 冠状动脉 **CT** 血管造影（**CTA**）：评估冠脉狭窄程度。

呼吸内科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 长期咳嗽、咳痰、咯血。
  - 发热、气促、呼吸困难、胸痛。
  - 哮喘、慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）、肺炎、肺结核、肺部结节、胸腔积液。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（重点关注吸烟史、职业暴露史）$\rightarrow$ 听诊肺部 $\rightarrow$ 开具检查。
- 需要准备的资料：既往胸片、胸部 CT 报告，肺功能检查报告，以及结核病史资料。
- 常见检查：
  - 胸片/胸部 **CT**：评估肺部病变。
  - 肺功能检查：评估呼吸功能。
  - 血气分析：评估氧合和酸碱状态。
  - 纤维支气管镜检查：诊断和治疗气道内病变。

消化内科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 腹痛、腹胀、恶心、呕吐、反酸、烧心。
  - 食欲不振、黄疸、大便习惯改变（便秘或腹泻）。
  - 胃炎、胃溃疡、肝硬化、胆囊炎、胰腺炎、结肠炎、消化道出血。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊 $\rightarrow$ 腹部触诊 $\rightarrow$ 开具检查 $\rightarrow$（等待）检查结果回诊。
- 需要准备的资料：既往胃镜、肠镜、腹部超声报告，肝功能、肿瘤标志物等血液检查结果。
- 常见检查：
  - 胃镜/肠镜：消化道最直接的检查手段。
  - 腹部彩色超声：评估肝、胆、胰、脾情况。
  - **C13/C14** 呼气试验：检查幽门螺杆菌感染。
  - 大便常规/潜血：评估消化道出血。

神经内科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 头痛、头晕（眩晕）、肢体麻木无力、手抖、走路不稳。
  - 短暂性意识丧失、癫痫、面瘫、失眠、记忆力下降。
  - 脑梗死（中风）、帕金森病、阿尔茨海默病（老年痴呆）、偏头痛。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（详细询问发病经过） $\rightarrow$ 神经系统查体（如腱反射、肌力） $\rightarrow$ 开具影像学检查。
- 需要准备的资料：头颅 CT/MRI 片子或报告，既往脑电图、颈部血管超声报告。
- 常见检查：
  - 头颅 **CT/MRI**：评估脑部病变。
  - 脑电图（**EEG**）：评估癫痫等疾病。
  - 肌电图/神经传导速度：评估周围神经病变。
  - 经颅多普勒（**TCD**）：评估脑血管血流情况。

普外科（普通外科）

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 各种腹部包块、体表肿物（如脂肪瘤、淋巴结肿大）。
  - 腹部剧烈疼痛（怀疑阑尾炎、胆囊炎、肠梗阻）。
  - 甲状腺结节、乳腺肿块、疝气（腹股沟疝）、痔疮。
  - 需要进行外科手术治疗的消化道良恶性肿瘤。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊 $\rightarrow$ 触诊检查 $\rightarrow$ 开具辅助检查（如超声、CT）。
- 需要准备的资料：体检报告中提示的结节、肿物或囊肿的超声报告和既往病理结果。

- 常见检查：
  - 腹部/甲状腺/乳腺超声：初步评估肿物性质。
  - 腹部 **CT**：评估腹腔脏器病变。
  - 血常规/急查血：评估是否存在炎症或急腹症。

骨科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 各种原因导致的疼痛、肿胀、活动受限（如关节痛、腰腿痛、颈椎痛）。
  - 外伤导致的骨折、脱位、软组织损伤。
  - 颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、骨关节炎、骨质疏松症。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（详细询问受伤/疼痛经过） $\rightarrow$ 查体（功能测试、叩诊） $\rightarrow$ 开具影像学检查。
- 需要准备的资料：既往所有 X 线片、CT、MRI 胶片或报告。
- 常见检查：
  - **X** 线平片（**DR**）：初步评估骨折、关节情况。
  - **CT/MRI**：评估椎间盘、韧带、软骨等软组织损伤。
  - 骨密度测定（**DEXA**）：诊断骨质疏松。

妇科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 白带异常、阴道出血、月经失调、痛经。
  - 妇科炎症（如阴道炎、盆腔炎）、子宫肌瘤、卵巢囊肿。
  - 宫颈病变筛查（TCT、HPV 阳性者）。
  - 计划生育咨询。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（详细询问月经史、婚育史） $\rightarrow$ 妇科检查（如需要，需排空膀胱） $\rightarrow$ 开具检查。
- 需要准备的资料：既往妇科超声报告、宫颈 TCT/HPV 结果、性激素六项报告。
- 常见检查：
  - 妇科超声（经腹/经阴道）：评估子宫附件情况。
  - 白带常规：诊断阴道炎症。
  - 宫颈 **TCT/HPV**：宫颈癌筛查。

产科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 确认妊娠（早孕检查、建档）。
  - 孕期产检、胎儿监测、妊娠期并发症（如妊娠期高血压、糖尿病）。
  - 临产征兆、产后检查。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（确认末次月经时间、既往妊娠史）$\rightarrow$ 测胎心、量腹围 $\rightarrow$ 开具产检化验单。
- 需要准备的资料：既往所有产检手册、超声报告、唐氏筛查、无创 DNA 等结果。
- 常见检查：
  - 产科超声：评估胎儿发育、羊水、胎盘。
  - 胎心监护：监测胎儿宫内安危。
  - 血、尿常规：孕期常规检查。
  - 唐氏筛查/无创 **DNA**：评估胎儿染色体异常风险。

儿科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 小儿发热、咳嗽、腹泻、呕吐、食欲不振。
  - 小儿肺炎、哮喘、手足口病、湿疹、过敏。
  - 小儿生长发育评估、营养咨询。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 测量体温、体重 $\rightarrow$ 医生问诊（主要由家长代述病情）$\rightarrow$ 查体 $\rightarrow$ 开具检查。
- 需要准备的资料：既往病历本、疫苗接种记录、近期的检查报告（如血常规 ）。
- 常见检查：
  - 血常规（指尖血）：快速评估有无细菌/病毒感染。
  - 胸片：评估有无肺炎。
  - 大便常规：评估腹泻原因。

皮肤科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
  - 皮疹、瘙痒、荨麻疹、湿疹、特应性皮炎。
  - 痤疮（青春痘）、带状疱疹、各种真菌感染（如脚气）、脱发。
  - 色素沉着、白癜风、各种疣体、痣的评估。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊（详细询问发病时间、用药史）$\rightarrow$ 医生肉眼观察皮损 $\rightarrow$ 开具检查。
- 需要准备的资料：既往用药清单，如有皮损照片可辅助诊断。
- 常见检查：
  - 真菌镜检：刮取皮屑，显微镜下寻找真菌。

    - 伍德灯检查：辅助诊断白癜风、某些真菌感染。
    - 皮肤活检：诊断复杂或疑难皮肤病。

泌尿外科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
    - 血尿、尿频、尿急、尿痛、排尿困难。
    - 肾结石、输尿管结石、膀胱结石。
    - 前列腺增生、泌尿系统肿瘤、男性不育、生殖器外伤。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊 $\rightarrow$ 查体 $\rightarrow$ 留取尿液或开具影像学检查。
- 需要准备的资料：既往尿常规报告、泌尿系超声/CT报告。
- 常见检查：
    - 尿常规/尿培养：诊断尿路感染。
    - 泌尿系统超声/CT：评估结石、肿瘤、前列腺情况。
    - 膀胱镜检查：观察膀胱内部情况。

耳鼻喉科（耳鼻咽喉头颈外科）

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
    - 耳痛、耳鸣、听力下降、中耳炎、眩晕。
    - 鼻塞、流涕、鼻出血、过敏性鼻炎、鼻窦炎。
    - 咽喉痛、声音嘶哑、扁桃体炎、打鼾（睡眠呼吸暂停）。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 医生问诊 $\rightarrow$ 鼻镜、耳镜或喉镜检查 $\rightarrow$ 开具听力或影像学检查。
- 需要准备的资料：既往听力图、鼻内镜报告。
- 常见检查：
    - 电子鼻咽喉镜：观察鼻腔、咽喉部结构。
    - 纯音测听/声导抗：评估听力情况。
    - 鼻窦 CT：诊断鼻窦炎。

眼科

- 常见症状 / 应该在该科就诊的情况：
    - 眼睛红肿、疼痛、视力下降、视物模糊、眼干、异物感。
    - 近视、远视、散光矫正（验光）。

    - 白内障、青光眼、结膜炎、角膜炎、糖尿病视网膜病变。
- 初诊流程：挂号 $\rightarrow$ 初步测视力 $\rightarrow$ 医生裂隙灯检查 $\rightarrow$ 眼底镜检查 $\rightarrow$ 开具特殊检查。
- 需要准备的资料：既往配镜处方、眼压测量记录、眼底照片。
- 常见检查：
    - 视力、眼压检查：基本评估。
    - 裂隙灯检查：观察眼前段病变。
    - 眼底照相/**OCT**（光学相干断层扫描）：评估视网膜、黄斑部病变。

第 6 章：患者高频问答（FAQ）

序号	常见问题（**FAQ**）	简洁、科普式回答
1	我不知道挂什么科怎么办？	请您前往门诊大厅的导诊台，向导诊护士详细描述您的主要症状，护士会依据《导诊手册》为您推荐合适的就诊科室。您也可以使用大厅的智能导诊机进行自助查询。
2	胃镜会不会很痛？	普通胃镜在进入喉咙时会有短暂的恶心和不适感，但并不会剧烈疼痛。如果担心不适，您可以选择无痛胃镜，它在麻醉下进行，整个过程您会处于睡眠状态，醒来后检查已完成。
3	核磁检查时间多长？	核磁共振（MRI）检查所需时间较长，依据检查部位和项目不同，通常需要**30 分钟到 60 分钟**不等。检查过程中请保持静止不动。
4	儿科挂号很难怎么办？	儿科号源紧张，建议您提前通过官方**App**或微信公众号进行线上预约挂号，并关注儿科专家的出诊时间。急症

		请直接前往急诊儿科。
5	急诊是不是比门诊快？	不一定。急诊按病情危重程度优先，而非挂号顺序。危重患者优先抢救。普通发热、慢性病复诊等非急症，在急诊可能需要长时间等待。
6	输液和口服药有什么区别？	输液（静脉输注）药物直接进入血液循环，起效快、药物浓度高，主要用于病情较重、需要快速控制感染或补液的情况。口服药则更方便，常用于病情稳定或轻症治疗。具体使用哪种方式，需由医生根据病情决定。
7	抽血为什么要空腹？	抽血检查中的血糖、血脂、肝功能等项目，会受到进食影响。空腹（禁食 8-12 小时）是为了排除饮食干扰，确保检验结果反映身体的基础代谢状态，从而更准确地评估健康状况。
8	报告单上的箭头是什么意思？	报告单上显示的 **$\uparrow$**（上箭头）表示该项目结果高于正常参考范围的上限；**$\downarrow$**（下箭头）表示该项目结果低于正常参考范围的下限。具体临床意义需结合医生诊断。
9	所有的检查报告都可以在自助机上打印吗？	大多数常规的化验和影像检查报告（如血常规、尿常规、胸片、CT）都可以在自助机上打印。部分特殊的报告（如病理报告、复杂的介入

		检查报告）可能需要到相应科室或人工窗口领取。
10	我可以要求医生给我开最好的药吗？	医生会根据您的病情、过敏史、经济承受能力和药物有效性等多方面因素，为您开具最合适和有效的药物，而不是盲目追求“最贵”或“最好”的药。
11	挂错号了怎么办？可以退吗？	若挂错号，请立即前往人工窗口或使用自助机办理退号手续（需在就诊时间开始前）。若已进入就诊时段，退号手续会更复杂，请尽快咨询工作人员。
12	门诊病历本丢了怎么办？	如果门诊病历本丢失，请立即到门诊收费处重新购买，并在下次就诊时向医生说明情况。重要检查检验报告原件建议妥善保管。
13	医保卡没带可以先自费吗？	可以先自费就诊。但请您保留好所有收费票据原件、检查报告和处方底方。您可以在规定时间内，携带这些资料到医保窗口或当地医保经办机构办理费用报销手续。
14	CT 辐射大吗？对人体有伤害吗？	CT 检查确实存在电离辐射，但现代医疗设备已将辐射剂量控制在安全范围内。在医疗诊断需要时，辐射带来的风险远小于漏诊或误诊的风险。请遵医嘱进行检查，非急重症不建议短期内频繁检查。
15	如何办理住院手续？	医生开具住院证后，您需持

		住院证、身份证明和医保卡到住院收费处缴纳预缴金，领取住院通知单，然后前往指定病区护士站报到。
16	办理出院手续需要多久？	出院结算通常需要等待医生和护士完成医嘱整理、费用核算等流程。一般在半小时到 1 小时内完成结算。请耐心等候病区护士通知。
17	探视时间是几点到几点？	本院探视时间一般为每日下午 3 点至 5 点。为了患者的休息和治疗，请家属严格遵守探视时间，非探视时间谢绝来访。
18	我是外地医保，如何报销？	外地医保（异地就医）患者，请务必在入院时告知住院处工作人员，并提供已在参保地办理异地就医备案的相关材料。否则可能无法直接结算，需回参保地报销。
19	为什么要做增强 CT/MRI？	增强扫描是向静脉注射造影剂后进行的扫描。造影剂能使病变组织和正常组织在影像上产生更大对比度，有助于发现和明确病灶性质、范围和血供情况，是诊断肿瘤和炎症的重要手段。
20	做 B 超需要空腹或憋尿吗？	腹部超声（肝、胆、胰、脾）需要空腹。泌尿系超声（膀胱、前列腺/子宫附件）需要憋尿（膀胱充盈）。请提前阅读检查单上的准备说明。

21	检查结果出来后，还需要重新挂号找医生看吗？	是的。检查结果只是诊断的一部分，您需要持结果回到原就诊医生处，由医生结合您的症状、查体和报告，综合判断病情并给出下一步诊疗方案。
22	医生让我复诊，我一定要挂原先那位医生吗？	如果您对原医生诊疗效果满意，建议挂原医生门诊以便保持治疗的连贯性。如原医生停诊或您有其他需求，也可挂同科室其他专家或主治医生。
23	门诊医生可以开住院证吗？	可以。如果门诊医生判断您的病情达到住院标准，会开具住院证，您凭住院证到住院处办理入院手续。
24	门诊可以开具病假条吗？	门诊医生可以根据您的病情，为您开具必要的诊断证明或病假建议，但是否批准病假需由您所在单位依据相关规定决定。
25	我可以自带药到医院使用吗？	住院期间使用的所有药物，原则上应由医院药房提供。为确保用药安全，请不要自行使用院外药物，如有特殊需求，请告知医生并遵医嘱处理。
26	医院有提供餐饮服务吗？	本院设有食堂，为住院患者提供订餐服务（如普通餐、糖尿病餐、流食等）。门诊患者可在门诊楼附近的美食广场或便利店购买食物。
27	怎么办理出院带药？	出院带药由主管医生根据病情开具，护士会在您办理完

		出院结算后，将药品和用药说明一并交给您，请仔细核对。
28	医院有提供免费轮椅服务吗？	有。门诊大厅、急诊大厅和各楼层分诊台均提供轮椅借用服务。您需要凭身份证缴纳押金后借用，并在使用完毕后归还。
29	药费可以退吗？	药品一旦从药房发出，非药品质量问题，根据药品管理规定一般不予退换。请在取药时仔细核对。
30	为什么做肠镜之前要喝那么多泻药？	喝泻药（清肠剂）是为了将肠道内容物完全清除，以便医生能清晰观察肠道黏膜，发现微小病变。肠道准备是否充分直接决定了肠镜检查的成功率和诊断准确性。
31	怀孕了可以拍 X 光片或 CT 吗？	原则上不建议。 X 光和 CT 检查具有辐射，可能对胎儿造成影响。如果您已怀孕或正在备孕，请务必提前告知医生和技师。
32	为什么有些检查需要提前预约？	部分检查（如 MRI、CT、内镜检查、特殊超声）机器数量有限、检查时间长或需要特殊准备，号源紧张，需要提前预约以合理安排时间。
33	报告上写的“不典型增生”是什么意思？	“不典型增生”通常指细胞形态发生了一些变化，介于正常和恶性之间，是一种癌前病变的描述。具体程度和处理方案需听取专科医生的建议。

34	我怎么知道药有没有副作用？	药品都会有说明书。医生开药时会告知您常见的副作用，并权衡利弊。如果您在用药过程中出现严重或无法耐受的不适，请立即咨询医生或药师。
35	什么是复苏室？	复苏室是手术室、内镜中心或麻醉科的区域，用于接受麻醉的患者在术后或检查后，由专业医护人员监测生命体征，直到患者麻醉清醒、生命体征平稳后才能离开。
36	为什么我不能带手机进入 MRI 检查室？	MRI 设备使用的是强大的磁场。手机、手表、银行卡等电子或磁性物品进入高磁场环境会被损坏，并可能对患者和设备安全造成严重威胁。
37	门诊的抽血结果多久能出来？	血常规和部分急查生化结果通常在 1-3 小时内出具。普通生化、免疫项目可能需半天或 1 个工作日。具体时间请咨询采血室护士。
38	缴费时可以刷医保卡个人账户支付自费部分吗？	医保卡个人账户可用于支付在医保定点医院就医时发生的自付费用，包括自费药、起付线以下费用等。具体支付范围请咨询收费窗口。
39	我可以帮别人代取药吗？	可以。代取药时请携带患者的就诊卡/医保卡、取药凭证和代取人的身份证明（如身份证），以便药师核对信息。
40	医生让我做活检是什么意思？	活检（病理检查）是取出一小块病变组织，进行显微镜

		下的病理学检查，这是目前判断肿瘤良性或恶性的金标准。医生会向您详细解释活检流程和风险。
41	为什么我需要做动态心电图而不是普通心电图？	动态心电图（**Holter**）可以连续记录 **24** 小时或更长时间的心电活动，捕捉到间歇性出现的心律失常或心肌缺血，这是普通心电图难以发现的。
42	医院可以开具出生证明吗？	婴儿的出生医学证明由接生该婴儿的产科统一管理和开具，您需在规定时间内，持双方身份证、户口本等证件到指定窗口办理。
43	我的体检报告有问题，应该挂什么科？	请根据报告上提示异常的项目，挂相应的科室。例如：肝功能异常挂消化内科；甲状腺结节挂普外科或内分泌科；血糖异常挂内分泌科。如果不确定，请咨询导诊台。
44	为什么无痛检查后不能自己开车？	无痛检查（如无痛胃镜、无痛肠镜）使用的麻醉药物会残留在体内，可能影响您的判断力、反应能力和协调能力，为确保交通安全，麻醉清醒后 24 小时内禁止驾车。
45	孩子哭闹会影响超声检查结果吗？	轻微的哭闹不会，但如果孩子剧烈挣扎、无法配合医生的体位调整，可能会影响超声图像采集的清晰度，从而影响诊断。请家长在检查时安抚好孩子。

46	护士叫我按压伤口，要按多久？	抽血或静脉输液拔针后，请用棉签或棉球垂直向下按压穿刺点至少 **5** 分钟，以防止皮下淤血或出血，切忌揉搓。
47	我可以要求医生给我开抗菌药物吗？	抗菌药物（抗生素）属于处方药，必须严格按照适应症使用。医生会根据您的病情判断是否为细菌感染，并决定是否需要使用。滥用抗菌药物可能导致细菌耐药。
48	医院的科室分布在哪里可以查到？	您可以在门诊大厅、各楼层电梯口查看楼层分布图，也可以使用大厅的智能导诊机或官方App查询科室位置和导航。
49	我想提前出院可以吗？	如果您坚持要求提前出院，医生会在详细告知您可能存在的风险后，请您签署《自动出院协议书》。出院后仍需按医嘱继续随访和治疗。
50	为什么我预约了，但还是需要等很久？	预约挂号是为了分配就诊时段，但门诊患者病情复杂，部分患者的诊疗时间会超出预期，导致医生看诊时间顺延。请您耐心等待，并听从诊区护士的安排。